Cuidado y valoración integral de la persona mayor

Breve descripción:

Este componente aborda los fundamentos para determinar y priorizar actividades de cuidado en la persona mayor según su nivel de dependencia. Integra normatividad vigente, procesos de envejecimiento, enfermedades frecuentes, bioseguridad, ambientes seguros y valoración funcional, con el fin de promover atención integral, digna, segura y orientada a la autonomía.

Septiembre 2026

Tabla de contenido

Introducción 5

1. Marco normativo y políticas públicas 8

1.1. Constitución Política y derechos de la persona mayor 8

1.2. Política pública de envejecimiento y vejez 11

1.3. Guías y protocolos vigentes para la atención a personas mayores 13

1.4. Responsabilidades del cuidador 15

2. Envejecimiento y ciclo vital 17

2.1. Conceptos clave 17

2.2. Ciclo vital y cambios propios del envejecimiento 19

3. Valoración del nivel de dependencia 22

3.1. Concepto de dependencia funcional 23

3.2. Tipos y niveles de dependencia 24

3.3. Identificación de necesidades de la persona mayor 26

4. Estados de conciencia 30

4.1. Niveles y características 30

5. Enfermedades en la persona mayor 33

5.1. Enfermedades frecuentes 34

5.2. Enfermedades contagiosas, manejo y medidas de protección 37

6. Ambientes seguros para el cuidado 43

6.1. Tipos de ambientes y condiciones del entorno domiciliario.....43

6.2. Criterios de seguridad y adaptaciones básicas del hogar 45

7. Bioseguridad en el cuidado.....49

7.1. Objetivos y principios de bioseguridad 49

7.2. Precauciones universales y elementos de protección personal.....51

8. Higiene y cuidado cefalocaudal 54

8.1. Objetivos 54

8.2. Procedimiento básico 55

8.3. Precauciones 58

9. Lavado de manos.....60

9.1. Importancia 60

9.2. Técnicas y elementos necesarios 61

10. Autocuidado y bienestar.....64

10.1. Autocuidado y autonomía de la persona mayor 64

10.2. Bienestar de la persona mayor y autocuidado del cuidador.....65

11. Nutrición y asistencia en la alimentación.....68

11.1. Nutrición, nutrientes y grupos de alimentos.....69

11.2. Dieta balanceada 73

11.3. Deficiencia nutricional 75

11.4. Fórmulas nutricionales 78

11.5. Técnicas de preparación de alimentos 80

11.6. Asistencia en la alimentación 82

Síntesis 85

Glosario 87

Referencias bibliográficas 89

Créditos 91

Introducción

El cuidado de la persona mayor constituye una responsabilidad social, familiar y ética que requiere conocimientos técnicos, sensibilidad humana y una comprensión integral del proceso de envejecimiento. Brindar un cuidado adecuado implica reconocer las características, capacidades y necesidades de cada persona, teniendo en cuenta su nivel de dependencia y favoreciendo su bienestar, seguridad, dignidad y autonomía.

El envejecimiento es un proceso natural del ciclo vital que puede estar acompañado de cambios físicos, psicológicos y sociales. Por ello, es importante identificar las condiciones que pueden influir en el desarrollo de las actividades de la vida diaria y proporcionar los apoyos necesarios, promoviendo la participación de la persona mayor.

Este componente formativo aborda aspectos relacionados con el envejecimiento, la valoración del nivel de dependencia, los derechos de la persona mayor, las enfermedades frecuentes, la seguridad del entorno, la bioseguridad, la higiene, el autocuidado y la alimentación. Estos elementos permiten fortalecer conocimientos y habilidades para brindar un cuidado integral, seguro y humanizado, centrado en la persona mayor.

Para complementar la comprensión de los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video.

Video 1. Cuidado y valoración integral de la persona mayor



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Cuidado y valoración integral de la persona mayor
Durante gran parte de la historia, las personas mayores han ocupado un lugar importante dentro de las familias y las comunidades. Su experiencia, conocimientos y memoria han sido fuente de aprendizaje para las nuevas generaciones. Sin embargo, la manera de comprender y acompañar la vejez ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy se reconoce que envejecer es un proceso natural del ciclo vital y que cada persona vive esta etapa de manera diferente. Algunas conservan una alta autonomía, mientras otras requieren apoyo para realizar determinadas actividades de la vida cotidiana. Esta diversidad hace necesario comprender que cuidar no significa simplemente hacer las cosas por alguien. Significa reconocer sus capacidades,

Transcripción del video. Cuidado y valoración integral de la persona mayor
identificar sus necesidades, prevenir riesgos y proporcionar el apoyo necesario, respetando siempre su dignidad, sus decisiones y su autonomía. El cuidado integral comprende aspectos que van más allá de la atención física. Incluye el reconocimiento de los derechos de la persona mayor, la valoración de su nivel de dependencia, la prevención de enfermedades y riesgos, la creación de ambientes seguros y la aplicación de medidas de bioseguridad. También contempla la higiene, el autocuidado, el bienestar, la nutrición y la asistencia durante la alimentación. De esta manera, el cuidado se convierte en una práctica que combina conocimiento técnico y sensibilidad humana, orientada a favorecer la seguridad, la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

1. Marco normativo y políticas públicas

El cuidado de la persona mayor no se limita a una práctica asistencial, sino que se fundamenta en principios constitucionales, normas legales y políticas públicas vigentes en Colombia. Estas disposiciones establecen un marco de protección que orienta las acciones del cuidador y garantizan pilares fundamentales en la atención, tales como la protección, la dignidad, el bienestar y la participación activa.

Estos pilares sintetizan el enfoque integral que debe orientar el cuidado. No se trata únicamente de suplir necesidades básicas, sino de proteger los derechos, respetar la dignidad humana, promover condiciones de bienestar y favorecer la participación de la persona mayor en las decisiones que afectan su vida.

Comprender este marco normativo permite al cuidador ejercer su labor con claridad ética y respaldo legal, asegurando que cada intervención contribuya al respeto, la autonomía y la calidad de vida de la persona mayor.

1.1. Constitución Política y derechos de la persona mayor

La protección de la persona mayor en Colombia se fundamenta en la Constitución Política de 1991, la cual reconoce la dignidad humana como eje central del ordenamiento jurídico. Desde este marco se establecen derechos fundamentales y principios que orientan la atención, protección y cuidado de las personas mayores.

La Constitución no solo reconoce derechos individuales, sino que también establece una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia para garantizar condiciones de vida dignas, seguras y libres de discriminación.

A continuación, se presentan algunos de los artículos constitucionales que sustentan la atención a la persona mayor:

Tabla 1. Fundamento constitucional de la protección a la persona mayor

Artículo constitucional	Derecho o principio protegido	¿En qué se basa?
Artículo 1	Dignidad humana	Colombia se fundamenta en el respeto por la dignidad humana.
Artículo 13	Igualdad y protección especial	Todas las personas son iguales ante la ley y el Estado protege a quienes se encuentran en condición de debilidad manifiesta.
Artículo 16	Libre desarrollo de la personalidad	Toda persona tiene derecho a desarrollar su personalidad sin limitaciones indebidas.
Artículo 46	Protección y asistencia a la persona mayor	El Estado, la sociedad y la familia concurren para la

Artículo constitucional	Derecho o principio protegido	¿En qué se basa?
		protección y asistencia de las personas mayores.
Artículo 48	Derecho a la seguridad social	La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio.
Artículo 49	Derecho a la salud	La atención en salud es un derecho fundamental y un servicio a cargo del Estado.

Estos artículos constituyen el marco jurídico que orienta las acciones relacionadas con el cuidado de la persona mayor. No se trata únicamente de atender necesidades básicas, sino de garantizar el respeto por los derechos fundamentales, promover la autonomía y prevenir cualquier forma de vulneración.

En este contexto, el cuidador cumple un papel fundamental al materializar estos principios en su práctica diaria, actuando con respeto, protegiendo la integridad y favoreciendo la participación de la persona mayor en las decisiones relacionadas con su cuidado.

1.2. Política pública de envejecimiento y vejez

El marco jurídico y político colombiano establece disposiciones orientadas a la protección integral de la persona mayor, las cuales sirven de base para el desarrollo de acciones de cuidado responsables y acordes con los derechos de esta población.

A continuación, se presenta una síntesis de algunas de las principales normas que sustentan la atención a la persona mayor en Colombia:

Tabla 2. Marco legal para la protección de la persona mayor en Colombia

Norma / Documento	¿Qué establece?	Derechos o garantías	Implicación en el cuidado
Ley 1251 de 2008	Establece medidas de protección, promoción y defensa de los derechos de la persona mayor.	Protección integral, bienestar físico y mental, participación social.	El cuidador previene situaciones de negligencia o abandono y promueve condiciones que favorecen la calidad de vida.
Ley 1315 de 2009	Regula las condiciones mínimas de funcionamiento de los	Ambientes seguros, atención idónea e	Garantiza condiciones seguras en

Norma / Documento	¿Qué establece?	Derechos o garantías	Implicación en el cuidado
	centros de protección social.	infraestructura adecuada.	instituciones y entornos domiciliarios.
Ley 1850 de 2017	Fortalece la protección contra el maltrato a la persona mayor mediante sanciones.	Protección contra violencia física, psicológica, económica y abandono.	Permite identificar, prevenir y reportar situaciones de maltrato o vulneración de derechos.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez establece un enfoque integral que orienta el cuidado hacia la promoción de la autonomía, la prevención de la dependencia y la garantía de los derechos de la persona mayor.

Esta política se estructura en componentes que orientan las acciones en diferentes contextos:

- Se promueve el envejecimiento activo, enfocado en mantener la funcionalidad e independencia el mayor tiempo posible.
- Se fortalece la protección social integral, garantizando el acceso a servicios de salud, seguridad social y condiciones básicas de bienestar.

- Se impulsa la participación e inclusión social, favoreciendo la integración comunitaria y el reconocimiento del rol de la persona mayor.
- Se desarrollan entornos protectores y seguros, orientados a prevenir riesgos físicos, sociales y ambientales.

Estos componentes refuerzan la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, y orientan el cuidado hacia el respeto por la dignidad humana, la participación y la seguridad.

En este contexto, el cuidador desempeña un papel fundamental, ya que es quien materializa estas disposiciones en la práctica cotidiana, asegurando que los derechos de la persona mayor se respeten y se traduzcan en acciones concretas de cuidado.

1.3. Guías y protocolos vigentes para la atención a personas mayores

La atención a la persona mayor requiere la aplicación de guías y protocolos que orienten las acciones del cuidador, garantizando prácticas seguras, organizadas y acordes con los lineamientos establecidos en el sector salud y social. Estos instrumentos permiten estandarizar los procesos de cuidado, reducir riesgos y asegurar una atención centrada en la persona.

Las guías corresponden a orientaciones técnicas basadas en evidencia que apoyan la toma de decisiones en el cuidado, mientras que los protocolos establecen procedimientos específicos para la ejecución de actividades.

Las guías y protocolos pueden ser emitidos por diferentes actores, los cuales cumplen funciones complementarias:

- **Entidades del Estado (principal fuente)**: en Colombia, las principales orientaciones las emiten entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, que establece lineamientos técnicos, guías de atención y protocolos en salud. También intervienen entidades territoriales, como las secretarías de salud, que adaptan estos lineamientos al contexto local.
- **Instituciones de salud (públicas y privadas)**: hospitales, clínicas y centros de atención desarrollan protocolos internos, los cuales deben estar basados en la normatividad vigente y en las orientaciones del Estado.
- **Organizaciones internacionales**: algunas guías se apoyan en recomendaciones de entidades como la Organización Mundial de la Salud, especialmente en temas de envejecimiento, cuidado integral y bioseguridad.
- **Instituciones de cuidado y formación**: centros geriátricos, hogares de paso y entidades de formación como el SENA también establecen lineamientos operativos para el cuidado, en coherencia con la normativa nacional.

En el contexto del cuidado de la persona mayor, estos lineamientos abordan aspectos como la higiene, la movilización, la alimentación, la adecuación del entorno, la prevención de riesgos y la bioseguridad.

En este sentido, el cuidador debe conocer, interpretar y aplicar estos lineamientos en su práctica diaria, asegurando una atención segura, responsable y centrada en las necesidades de la persona mayor.

1.4. Responsabilidades del cuidador

El reconocimiento de los derechos de la persona mayor implica, de manera directa, responsabilidades para quienes ejercen funciones de cuidado. En el contexto colombiano, el cuidador, ya sea familiar o formal, no solo desempeña una labor asistencial, sino que asume un compromiso ético, social y legal orientado a garantizar la protección, la dignidad y el bienestar.

La Ley 1251 de 2008 establece medidas para la protección, promoción y defensa de los derechos de la persona mayor, destacando la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia en la garantía de condiciones adecuadas de vida. Esta norma refuerza la obligación de brindar un trato digno y de prevenir cualquier forma de abandono, negligencia o maltrato.

De igual manera, la Ley 1850 de 2017 fortalece la protección frente al maltrato contra la persona mayor, al establecer sanciones para conductas como el abandono, la violencia física, psicológica o económica y la omisión de cuidados básicos.

En este marco, el cuidador debe actuar con responsabilidad, respeto y compromiso en el ejercicio de sus funciones. Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Garantizar un trato digno y respetuoso en todo momento.
- Velar por condiciones adecuadas de higiene, alimentación y seguridad.
- Facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud y protección social.
- Identificar y reportar situaciones de vulneración de derechos.
- Prevenir riesgos asociados a caídas, negligencia o aislamiento social.

El cuidado debe orientarse por principios de dignidad humana, corresponsabilidad y enfoque diferencial, teniendo en cuenta el nivel de dependencia y las condiciones particulares de cada persona mayor.

De esta manera, el rol del cuidador trasciende la asistencia básica y se consolida como un actor fundamental en la garantía de los derechos y en la implementación práctica de las políticas de envejecimiento y vejez.

2. Envejecimiento y ciclo vital

Luego de comprender el marco normativo que protege a la persona mayor y orienta el ejercicio del cuidado, es necesario abordar el proceso de envejecimiento desde una perspectiva biológica, psicológica y social. El conocimiento de los cambios propios de esta etapa del ciclo vital permite identificar necesidades, establecer prioridades y orientar adecuadamente las acciones de cuidado según el nivel de dependencia.

El envejecimiento no es una enfermedad, sino un proceso natural, progresivo e irreversible que forma parte del ciclo vital humano. Este proceso implica transformaciones físicas, funcionales, cognitivas y sociales, las cuales pueden presentarse de manera diferente en cada persona, dependiendo de sus condiciones de salud, su entorno y sus estilos de vida.

Comprender el envejecimiento desde una visión integral facilita el desarrollo de prácticas de cuidado más adecuadas, respetuosas y centradas en la persona, reconociendo sus capacidades, limitaciones y necesidades particulares.

2.1. Conceptos clave

El envejecimiento es un proceso natural, progresivo e irreversible que forma parte del ciclo vital humano. Este proceso implica cambios físicos, psicológicos y sociales que pueden influir en la funcionalidad y autonomía de la persona. Su manifestación varía en cada individuo, ya que está determinada por factores como las condiciones de salud, los estilos de vida, el entorno y las condiciones socioeconómicas.

Comprender el envejecimiento desde una perspectiva integral permite orientar el cuidado de manera adecuada, reconociendo tanto las capacidades como las necesidades de la persona mayor. En este contexto, es importante diferenciar algunos conceptos clave que aportan a la comprensión de esta etapa:

- **Envejecimiento**: proceso continuo de transformación que experimenta el ser humano a lo largo de la vida, caracterizado por cambios que pueden afectar la funcionalidad, sin que esto implique necesariamente enfermedad.
- **Persona mayor**: término utilizado en el ámbito normativo y social para referirse a las personas de 60 años o más, reconociéndolas como sujetos de derechos y promoviendo un enfoque de respeto e inclusión.
- **Geriatría**: rama de la medicina especializada en la atención de la persona mayor, enfocada en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, con el propósito de mantener la funcionalidad y mejorar la calidad de vida.
- **Adulto mayor**: denominación comúnmente empleada para referirse a las personas de 60 años o más. Aunque sigue en uso, ha sido reemplazada progresivamente por el término «persona mayor», por considerarse más inclusivo.
- **Gerontología**: disciplina que estudia el envejecimiento desde una perspectiva integral, abordando aspectos biológicos, psicológicos y sociales, con el fin de comprender las condiciones de vida de la persona mayor y promover su bienestar.

- **Edad mayor**: expresión general que hace referencia a la etapa del ciclo vital en la que se presentan los cambios asociados al envejecimiento, generalmente a partir de los 60 años.

El reconocimiento de estos conceptos permite comprender el envejecimiento como un proceso diverso y dinámico, facilitando la toma de decisiones en el cuidado y promoviendo una atención centrada en la persona, respetuosa de su dignidad, autonomía y calidad de vida.

2.2. Ciclo vital y cambios propios del envejecimiento

El ciclo vital es el proceso continuo de desarrollo que experimenta el ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. Cada etapa está marcada por transformaciones físicas, psicológicas y sociales que influyen en la forma en que la persona se adapta a su entorno y responde a sus necesidades.

La adultez mayor constituye una etapa del ciclo vital caracterizada por cambios progresivos asociados al paso del tiempo. En Colombia, se considera persona mayor a quien tiene 60 años o más, según la Ley 1251 de 2008. Sin embargo, la edad cronológica no determina por sí sola la funcionalidad, ya que el envejecimiento es un proceso individual influenciado por factores genéticos, estilos de vida, condiciones socioeconómicas y acceso a servicios de salud.

En el plano biológico, el envejecimiento implica una disminución gradual de la capacidad de regeneración celular y adaptación fisiológica.

Estos cambios pueden manifestarse en diferentes dimensiones:

- **Cambios físicos y funcionales**
    - Disminución de la fuerza muscular y la resistencia.
    - Reducción de la elasticidad de la piel.
    - Alteraciones en el equilibrio y la coordinación.
    - Disminución de la agudeza visual y auditiva.
    - Mayor prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y artrosis.
- **Cambios cognitivos**
    - Disminución leve en la velocidad de procesamiento de la información.
    - Posibles dificultades en la memoria reciente.
    - Conservación de conocimientos, experiencias y habilidades adquiridas a lo largo de la vida.
- **Cambios emocionales y sociales**
    - Transición a la jubilación y cambios en el rol productivo.
    - Reconfiguración de las dinámicas familiares.
    - Posible reducción de redes sociales.
    - Necesidad de reconocimiento y participación activa.

El envejecimiento no debe entenderse únicamente como un proceso de pérdida, sino también como una etapa de consolidación de experiencias, saberes y adaptación. Muchas personas mayores mantienen autonomía, independencia y capacidad de toma de decisiones.

Desde el enfoque de curso de vida adoptado por el sistema de salud colombiano (Resolución 3280 de 2018), la atención se orienta a mantener la funcionalidad el mayor

tiempo posible, prevenir el deterioro innecesario y fortalecer las capacidades existentes.

Comprender los cambios propios del envejecimiento permite reconocer las condiciones que pueden influir en la autonomía de la persona mayor y orientar el cuidado de manera adecuada. En este sentido, el abordaje integral de esta etapa se apoya en disciplinas especializadas que estudian el envejecimiento desde diferentes perspectivas, como la geriatría y la gerontología.

3. Valoración del nivel de dependencia

El envejecimiento puede estar acompañado de cambios que influyen en la capacidad de la persona mayor para realizar de manera independiente algunas actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, la edad por sí sola no determina la pérdida de autonomía ni la necesidad de recibir cuidados. Cada persona experimenta el envejecimiento de manera diferente, de acuerdo con sus condiciones de salud, capacidades, entorno, estilos de vida y redes de apoyo.

En este contexto, valorar el nivel de dependencia permite reconocer las capacidades y necesidades de la persona mayor, así como determinar el apoyo que requiere para realizar sus actividades cotidianas. Esta valoración constituye un elemento fundamental para orientar el cuidado, establecer prioridades y promover la autonomía de acuerdo con las posibilidades de cada persona.

La valoración debe realizarse de manera individual, respetuosa y centrada en la persona, teniendo en cuenta que las necesidades de apoyo pueden variar según la actividad y las condiciones particulares. Por ello, es importante que el cuidador identifique no solo las limitaciones, sino también las capacidades que la persona conserva y puede desarrollar con el apoyo adecuado.

A partir de esta valoración, es posible establecer acciones de cuidado proporcionales a las necesidades identificadas, evitando tanto la falta de asistencia como la sobreasistencia. De esta manera, el cuidador contribuye a preservar la autonomía, prevenir riesgos y favorecer el bienestar y la calidad de vida de la persona mayor.

3.1. Concepto de dependencia funcional

La dependencia funcional se refiere a la necesidad de apoyo que puede presentar una persona para realizar actividades de la vida cotidiana, debido a una disminución o limitación de sus capacidades físicas, cognitivas, sensoriales o psicológicas. Esta necesidad de apoyo puede ser temporal o permanente y variar según las condiciones particulares de cada persona y las actividades que realiza.

La dependencia funcional no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Una persona mayor puede conservar un alto grado de autonomía y realizar por sí misma la mayoría de sus actividades, mientras que otra puede requerir diferentes niveles de apoyo debido a enfermedades, discapacidad, deterioro de algunas capacidades o situaciones relacionadas con su entorno.

Para comprender la dependencia funcional es necesario diferenciarla de la autonomía y la independencia. La autonomía se relaciona con la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida y expresar preferencias, mientras que la independencia hace referencia a la posibilidad de realizar actividades cotidianas por cuenta propia. Una persona puede requerir apoyo para realizar una actividad y, al mismo tiempo, conservar su capacidad para tomar decisiones sobre cómo desea recibir dicho apoyo.

Las actividades de la vida diaria permiten identificar las capacidades funcionales de la persona y las necesidades de asistencia. Entre ellas se encuentran:

- **Actividades básicas de la vida diaria**: relacionadas con el cuidado personal y las necesidades esenciales, como alimentarse, bañarse, vestirse, realizar el aseo personal, desplazarse y utilizar el sanitario.

- **Actividades instrumentales de la vida diaria**: necesarias para desenvolverse de manera independiente en el entorno, como preparar alimentos, realizar compras, manejar dinero, utilizar medios de comunicación, administrar medicamentos o realizar actividades domésticas.

La valoración de la dependencia debe centrarse en lo que la persona puede hacer, lo que requiere apoyo para realizar y el tipo de asistencia que necesita, evitando sustituir innecesariamente sus capacidades. De esta manera, el cuidador puede proporcionar un apoyo proporcional a sus necesidades, promover la participación y preservar el mayor grado de autonomía posible.

En consecuencia, comprender el concepto de dependencia funcional constituye un elemento fundamental para orientar las actividades de cuidado de acuerdo con el grado de autonomía de la persona mayor y favorecer su bienestar, seguridad y calidad de vida.

3.2. Tipos y niveles de dependencia

La dependencia funcional puede analizarse teniendo en cuenta las capacidades que se encuentran limitadas y el grado de apoyo que requiere la persona para realizar sus actividades cotidianas. Esta diferenciación permite al cuidador reconocer las necesidades particulares de cada persona mayor y ajustar la asistencia de acuerdo con sus capacidades, evitando tanto la falta de apoyo como la realización innecesaria de actividades que puede desarrollar por sí misma.

Según las capacidades que pueden encontrarse afectadas, se pueden identificar diferentes manifestaciones de dependencia:

- **Dependencia física**: se relaciona con limitaciones en la fuerza, movilidad, equilibrio o coordinación que dificultan actividades como caminar, levantarse, bañarse, vestirse o desplazarse.
- **Dependencia cognitiva**: se presenta cuando existen dificultades relacionadas con la memoria, la orientación, la atención, el juicio o la capacidad para comprender y responder adecuadamente a determinadas situaciones. Estas dificultades pueden afectar actividades como el manejo de medicamentos, la organización de tareas o la identificación de situaciones de riesgo.
- **Dependencia sensorial**: está relacionada con limitaciones importantes de la visión, la audición u otras capacidades sensoriales que pueden dificultar la comunicación, la movilidad y la interacción segura con el entorno.

Las condiciones sociales y ambientales también pueden influir en la necesidad de apoyo. La ausencia de redes familiares o comunitarias, las barreras físicas del entorno y las condiciones de vulnerabilidad pueden dificultar el desarrollo independiente de las actividades cotidianas. Por esta razón, estos factores deben considerarse durante la valoración, aunque no constituyan por sí mismos un tipo de dependencia funcional.

De acuerdo con el grado de apoyo requerido, pueden reconocerse diferentes niveles de dependencia:

- **Dependencia leve**: la persona realiza la mayoría de sus actividades de manera independiente, pero requiere apoyo ocasional, supervisión o asistencia para algunas tareas específicas.
- **Dependencia moderada**: la persona presenta dificultades para realizar varias actividades cotidianas y requiere apoyo frecuente para acciones como la movilidad, la higiene, el vestido o la alimentación.
- **Dependencia severa**: la persona presenta limitaciones importantes y requiere asistencia continua o permanente para realizar gran parte de las actividades básicas de la vida diaria.

Es importante comprender que estos niveles no son necesariamente estáticos. Las capacidades y necesidades de apoyo pueden cambiar debido a modificaciones en el estado de salud, procesos de rehabilitación, condiciones del entorno u otras circunstancias. Por ello, la valoración debe realizarse de manera individual y actualizarse cuando se presenten cambios relevantes.

La identificación del tipo y nivel de dependencia permite orientar las actividades de cuidado de acuerdo con las necesidades reales de la persona mayor. De esta manera, el cuidador puede priorizar las acciones, proporcionar el apoyo necesario y favorecer la participación de la persona en aquellas actividades que todavía puede realizar, contribuyendo a preservar su autonomía, seguridad y calidad de vida.

3.3. Identificación de necesidades de la persona mayor

Una vez reconocido el tipo y nivel de dependencia, el siguiente paso en el proceso de cuidado consiste en identificar las necesidades particulares de la persona

mayor. Esta identificación debe considerar diferentes dimensiones de su vida, incluyendo aspectos físicos, emocionales, sociales y ambientales, con el propósito de orientar las acciones de cuidado de acuerdo con sus capacidades, preferencias y condiciones particulares.

Las necesidades pueden variar según el estado de salud, el nivel de funcionalidad, el entorno, las relaciones familiares y las redes de apoyo disponibles. Por esta razón, la valoración debe realizarse de manera individualizada, evitando generalizaciones basadas únicamente en la edad o en la presencia de una condición de salud.

Entre las principales dimensiones que pueden considerarse en la identificación de necesidades se encuentran:

Tabla 3. Necesidades de la persona mayor según dimensión

Dimensión	**Necesidades principales**	**Riesgos asociados a una atención inadecuada**	**Implicación para el cuidado**
Necesidades básicas	Alimentación e hidratación adecuadas, higiene personal, eliminación, descanso y movilidad segura.	Deshidratación, desnutrición, infecciones, lesiones y deterioro de la funcionalidad.	Brindar apoyo o supervisión en las actividades básicas de acuerdo con el nivel de dependencia.

Dimensión	Necesidades principales	Riesgos asociados a una atención inadecuada	Implicación para el cuidado
Seguridad	Entorno seguro, iluminación adecuada, prevención de caídas y uso seguro de elementos y medicamentos según las indicaciones establecidas.	Caídas, accidentes, lesiones y otras situaciones que pueden comprometer la integridad de la persona.	Identificar factores de riesgo y favorecer condiciones seguras en el entorno.
Emocionales	Acompañamiento, escucha, afecto, reconocimiento, respeto y expresión de sentimientos.	Soledad, aislamiento, ansiedad, tristeza y disminución del bienestar.	Favorecer la comunicación, el acompañamiento y la expresión de necesidades y preferencias.
Sociales	Interacción con familiares, amigos y comunidad, fortalecimiento de redes de apoyo y	Aislamiento social, pérdida de vínculos y disminución de la participación.	Promover la interacción y participación social de acuerdo con los intereses y

Dimensión	Necesidades principales	Riesgos asociados a una atención inadecuada	Implicación para el cuidado
	participación en actividades.		capacidades de la persona.
Autonomía y participación	Toma de decisiones, conservación de habilidades y participación en actividades según sus capacidades.	Pérdida innecesaria de autonomía, disminución de habilidades y dependencia por sobreprotección.	Facilitar que la persona realice por sí misma las actividades que puede desarrollar y proporcionar apoyo cuando lo requiera.

La identificación de estas necesidades permite establecer prioridades y determinar las actividades de cuidado que requieren mayor atención. Asimismo, facilita adaptar el apoyo a las capacidades reales de la persona mayor, respetar sus decisiones y prevenir situaciones de riesgo.

En este proceso, el cuidador debe detectar cambios en las condiciones de la persona, comunicar oportunamente las situaciones que requieran atención y actuar dentro de sus funciones y competencias. El propósito no es sustituir las capacidades de la persona mayor, sino proporcionar el apoyo necesario para favorecer su autonomía, seguridad, bienestar y calidad de vida.

4. Estados de conciencia

El estado de conciencia corresponde a la condición que permite a una persona mantenerse despierta, percibir lo que ocurre a su alrededor, responder a estímulos y relacionarse con el entorno. Su valoración es importante durante el cuidado de la persona mayor, ya que permite reconocer cambios en su estado habitual y determinar si requiere mayor supervisión o atención.

El nivel de conciencia puede variar temporalmente debido a diferentes situaciones, como alteraciones del sueño, efectos de medicamentos, enfermedades, infecciones, cambios metabólicos, lesiones u otras condiciones que afecten el funcionamiento del organismo. Por esta razón, el cuidador debe conocer las características generales de los diferentes niveles y prestar atención a cambios respecto al estado habitual de la persona.

La valoración del estado de conciencia debe realizarse mediante la observación de aspectos como el nivel de alerta, la capacidad para responder a estímulos, la orientación y la interacción con el entorno. El cuidador no establece diagnósticos, pero sí puede reconocer cambios significativos y comunicarlos oportunamente al personal de salud o a la persona responsable de la atención.

4.1. Niveles y características

El estado de conciencia puede presentar diferentes niveles, determinados principalmente por el grado de alerta, la capacidad de responder a estímulos y la interacción de la persona con el entorno. Reconocer estas características permite al

cuidador identificar cambios respecto al estado habitual de la persona mayor y actuar de manera oportuna, especialmente cuando se presentan alteraciones repentinas.

De manera general, los niveles de conciencia pueden describirse de la siguiente manera:

- **Alerta**: la persona permanece despierta, mantiene una interacción adecuada con el entorno, comprende las situaciones que se le presentan y responde de manera coherente a estímulos y preguntas.
- **Somnolencia**: la persona presenta tendencia al sueño, pero puede despertarse mediante estímulos verbales o físicos leves y responder cuando se le solicita. Una vez que cesa el estímulo, puede volver a quedarse dormida.
- **Obnubilación**: se percibe una disminución del nivel de alerta y de la capacidad para interactuar con el entorno. Las respuestas pueden ser lentas, confusas o poco precisas, y puede existir dificultad para mantener la atención.
- **Estupor**: la persona presenta una alteración importante del nivel de conciencia y permanece generalmente sin respuesta espontánea. Puede reaccionar únicamente ante estímulos intensos, pero la respuesta suele ser limitada y breve.
- **Coma**: corresponde a un estado profundo de pérdida de conciencia en el que la persona no puede despertarse y no presenta respuestas voluntarias adecuadas ante estímulos externos.

Durante el cuidado cotidiano, además del nivel de alerta, es importante detectar otros aspectos relacionados con el estado de conciencia:

- Capacidad para mantener los ojos abiertos y permanecer despierta.
- Respuesta a estímulos verbales y físicos.
- Capacidad para comprender y responder preguntas.
- Orientación respecto a sí misma, el lugar y el momento.
- Cambios repentinos en el comportamiento o la interacción.
- Presencia de confusión, desorientación o respuestas diferentes a las habituales.

El estado de conciencia puede verse afectado por diferentes situaciones, entre ellas enfermedades, infecciones, alteraciones metabólicas, efectos de medicamentos, consumo de sustancias, traumatismos, falta de oxígeno o cambios importantes en el estado de salud. Por esta razón, un cambio repentino en el nivel de conciencia debe considerarse una situación que requiere atención oportuna.

El cuidador debe conocer el estado habitual de la persona mayor para poder identificar modificaciones significativas. Ante un cambio repentino, debe mantener la seguridad de la persona, evitar dejarla sola, informar oportunamente al responsable de su atención y solicitar valoración por parte del personal de salud cuando sea necesario. El cuidador no debe intentar establecer la causa del cambio ni realizar procedimientos para los cuales no está capacitado.

El reconocimiento de los diferentes niveles de conciencia permite adaptar la comunicación, la supervisión y las actividades de cuidado a las condiciones de la persona mayor. De esta manera, se favorece una atención segura, respetuosa y acorde con sus capacidades y necesidades.

5. Enfermedades en la persona mayor

El proceso de envejecimiento puede estar acompañado por diferentes condiciones de salud que influyen en el bienestar, la capacidad funcional y el nivel de autonomía de la persona mayor. Algunas enfermedades son crónicas y requieren seguimiento permanente, mientras que otras pueden presentarse de manera aguda y generar cambios importantes en el estado general de la persona.

En esta etapa de la vida también es frecuente la presencia simultánea de varias enfermedades, situación conocida como multimorbilidad, que puede aumentar la complejidad del cuidado y favorecer la aparición de riesgos asociados al tratamiento y al deterioro funcional.

Para el cuidador, conocer las enfermedades más frecuentes no significa realizar diagnósticos ni modificar tratamientos. Su función consiste en observar cambios en el estado de la persona mayor, reconocer señales de alerta, apoyar las indicaciones establecidas por los profesionales de salud y adaptar las actividades de cuidado de acuerdo con sus necesidades y nivel de dependencia.

De igual manera, algunas enfermedades pueden ser transmisibles y representar un riesgo para la persona mayor, el cuidador y otras personas del entorno. Por esta razón, además del reconocimiento de las enfermedades frecuentes, es necesario conocer las principales enfermedades contagiosas, sus formas de transmisión y las medidas de prevención y protección aplicables durante el cuidado.

5.1. Enfermedades frecuentes

La persona mayor puede presentar diferentes enfermedades y condiciones de salud que pueden influir en su bienestar, capacidad funcional y nivel de autonomía.

Es importante tener en cuenta que:

- El envejecimiento no es una enfermedad, sino un proceso natural del ciclo vital.
- Los cambios propios del envejecimiento pueden aumentar la vulnerabilidad frente a algunas condiciones de salud.
- Es posible que una persona mayor presente varias enfermedades al mismo tiempo, situación conocida como multimorbilidad.
- Una enfermedad puede afectar la movilidad, la alimentación, el descanso, la orientación, la comunicación o la capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana.
- La presencia de una enfermedad no significa necesariamente que la persona haya perdido su autonomía. El apoyo requerido depende de sus capacidades y necesidades particulares.

Entre las enfermedades que pueden presentarse con frecuencia en la persona mayor se encuentran la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la artrosis, la osteoporosis, el deterioro cognitivo y las demencias, y la depresión. Además, existen condiciones y síndromes geriátricos de especial importancia para el cuidado, como la fragilidad, las caídas y la incontinencia urinaria. La polifarmacia, por su parte, puede aumentar los riesgos asociados al uso simultáneo de varios medicamentos.

Estas enfermedades y condiciones pueden afectar de diferentes maneras la capacidad de la persona mayor para realizar sus actividades cotidianas. Por esta razón, el cuidador debe prestar atención no solo a la enfermedad, sino también a cómo esta modifica la autonomía, la movilidad, la participación y las necesidades de apoyo.

Tabla 4. Enfermedades y condiciones frecuentes

Enfermedad o condición	Posible impacto en la persona mayor	Señales de alerta para el cuidador
Hipertensión y enfermedades cardiovasculares	Fatiga, mareo o menor tolerancia al esfuerzo.	Dolor torácico, dificultad para respirar, edema o cambios bruscos en el estado general.
Diabetes mellitus	Puede afectar la energía, la visión y el cuidado de la piel.	Sudoración fría, confusión, debilidad o heridas que no cicatrizan.
Artrosis y osteoporosis	Dolor, limitación de la movilidad y mayor riesgo de fracturas.	Dificultad para caminar o caídas repetidas.
Deterioro cognitivo y demencias	Dificultades en la memoria, orientación y realización de actividades cotidianas.	Desorientación, cambios conductuales u olvidos frecuentes.

Enfermedad o condición	Posible impacto en la persona mayor	Señales de alerta para el cuidador
Depresión	Disminución de la motivación y participación en las actividades.	Aislamiento, pérdida de interés o alteraciones del sueño.
Fragilidad	Debilidad y mayor vulnerabilidad ante situaciones de salud.	Pérdida involuntaria de peso, debilidad o lentitud al caminar.
Caídas	Pueden ocasionar lesiones, fracturas y pérdida de autonomía.	Inestabilidad o uso inseguro de ayudas técnicas.
Incontinencia urinaria	Puede afectar la autoestima, la higiene y la integridad de la piel.	Humedad constante, irritación o lesiones en la piel.
Polifarmacia	Mayor riesgo de interacciones y efectos adversos.	Somnolencia excesiva, mareos o confusión.

El cuidador no diagnostica enfermedades ni modifica tratamientos. Su función consiste en observar cambios respecto al estado habitual de la persona mayor, apoyar las actividades de acuerdo con su nivel de autonomía, prevenir riesgos y seguir las indicaciones establecidas por los profesionales de salud.

Cuando se presenten cambios repentinos o señales de alerta, como dificultad para respirar, dolor intenso, alteraciones de la conciencia o la orientación, debilidad marcada, caídas, lesiones o cambios importantes en el comportamiento, debe informar oportunamente y solicitar la atención correspondiente, de acuerdo con los protocolos establecidos.

El cuidado debe ser proporcional a las capacidades de la persona mayor. Siempre que sea posible, se debe favorecer su participación en las actividades que pueda realizar de manera segura, evitando sustituir innecesariamente sus capacidades. De esta manera, el cuidador contribuye a preservar la autonomía, la dignidad y la calidad de vida de la persona mayor.

5.2. Enfermedades contagiosas, manejo y medidas de protección

Las enfermedades contagiosas, también llamadas enfermedades transmisibles, son aquellas que pueden pasar de una persona a otra, de un animal a una persona o a través de alimentos, agua, objetos o superficies contaminadas. Durante el cuidado de la persona mayor es importante conocer las principales formas de transmisión y aplicar medidas que reduzcan el riesgo de contagio.

La persona mayor puede ser más vulnerable frente a algunas infecciones y, en determinados casos, estas pueden evolucionar rápidamente y afectar su estado general y su capacidad funcional. Además, una infección no siempre se manifiesta de la misma manera. En algunas personas mayores pueden aparecer cambios como debilidad, somnolencia o desorientación, incluso cuando otros síntomas habituales son leves o no están presentes.

Entre las enfermedades contagiosas que pueden presentarse con frecuencia se encuentran las infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales y cutáneas. Algunas de ellas pueden estar relacionadas con las condiciones de higiene, el contacto con personas enfermas, la manipulación de alimentos o el cuidado inadecuado de heridas y lesiones en la piel.

Tabla 5. Enfermedades contagiosas frecuentes

Tipo de infección	Manifestaciones que puede observar el cuidador	Riesgos	Acciones de cuidado
Infecciones respiratorias	Tos, dificultad para respirar, debilidad, fiebre o cambios repentinos en el estado general.	Deterioro del estado respiratorio y funcional.	Vigilar cambios respiratorios, favorecer la ventilación de los espacios y aplicar las medidas de protección indicadas.
Infecciones urinarias	Malestar general, somnolencia, irritabilidad o cambios repentinos en la orientación.	Deterioro del estado general y complicaciones que requieren	Mantener una adecuada higiene, favorecer la hidratación cuando no exista

Tipo de infección	Manifestaciones que puede observar el cuidador	Riesgos	Acciones de cuidado
		atención profesional.	contraindicación y comunicar oportunamente los cambios.
Infecciones gastrointestinales	Diarrea, vómito, debilidad y signos de deshidratación.	Deshidratación y deterioro rápido del estado general.	Mantener medidas de higiene alimentaria, vigilar la hidratación y observar signos de alarma.
Infecciones cutáneas	Enrojecimiento, secreción, dolor localizado o cambios en heridas y lesiones.	Extensión de la infección y afectación del estado general.	Mantener una adecuada higiene, realizar el cuidado de las heridas según las indicaciones recibidas y observar

Tipo de infección	Manifestaciones que puede observar el cuidador	Riesgos	Acciones de cuidado
			periódicamente el estado de la piel.

Las manifestaciones, riesgos y acciones anteriores se encuentran desarrollados en el documento de referencia y se han organizado aquí desde aquello que resulta relevante para la observación y el cuidado.

Cuando la persona mayor presenta síntomas compatibles con una enfermedad contagiosa, el cuidador debe actuar con precaución para proteger tanto a la persona atendida como a sí mismo y a quienes se encuentran en el entorno.

Durante el cuidado es importante:

- Prestar atención y registrar los cambios respecto al estado habitual de la persona.
- Informar oportunamente los signos o síntomas relevantes a la persona responsable o al profesional de salud.
- Mantener una adecuada higiene de manos antes y después del contacto con la persona mayor y después de manipular elementos potencialmente contaminados.
- Utilizar los elementos de protección personal cuando estén indicados según el riesgo y las actividades que se van a realizar.

- Evitar compartir objetos de uso personal cuando exista riesgo de transmisión.
- Mantener limpios y desinfectados los elementos y superficies que puedan estar contaminados.
- Favorecer la ventilación de los espacios, especialmente cuando existen síntomas respiratorios.
- Limitar temporalmente el contacto con otras personas cuando las condiciones de salud o las indicaciones sanitarias así lo requieran.
- Seguir las indicaciones del personal de salud y los protocolos establecidos.

La prevención de las enfermedades contagiosas requiere la aplicación conjunta de diferentes medidas. La higiene de manos, la limpieza y desinfección de superficies, la ventilación adecuada y el cumplimiento de las medidas de protección indicadas contribuyen a disminuir el riesgo de transmisión.

La vacunación también constituye una medida importante para prevenir algunas enfermedades transmisibles. El cuidador puede contribuir al cumplimiento del esquema de vacunación vigente y facilitar el acceso a los servicios de salud cuando corresponda.

Es importante recordar que el cuidador no diagnostica la infección ni modifica por cuenta propia los medicamentos o tratamientos. Su responsabilidad consiste en aplicar las medidas de protección correspondientes, brindar el apoyo requerido, observar los cambios en el estado de la persona y comunicar oportunamente cualquier situación relevante.

Ante signos como dificultad para respirar, alteraciones repentinas de la conciencia o la orientación, debilidad marcada, vómitos o diarrea persistentes, signos de deshidratación, fiebre u otros cambios importantes, se debe solicitar valoración por parte del personal de salud de acuerdo con los protocolos establecidos.

La aplicación adecuada de estas medidas contribuye a disminuir el riesgo de transmisión de infecciones y favorece un cuidado seguro, protegiendo a la persona mayor, al cuidador y a las demás personas del entorno.

6. Ambientes seguros para el cuidado

El entorno donde vive y realiza sus actividades la persona mayor influye directamente en su seguridad, autonomía y calidad de vida. Los cambios relacionados con la movilidad, la fuerza muscular, la visión, el equilibrio o las capacidades cognitivas pueden aumentar la posibilidad de accidentes cuando el espacio no responde a sus necesidades.

Un ambiente seguro no consiste únicamente en mantener el lugar limpio y ordenado. También implica identificar riesgos, facilitar el desplazamiento, disponer los objetos de manera accesible y realizar los ajustes necesarios de acuerdo con las capacidades y el nivel de dependencia de la persona mayor.

La adecuación del entorno debe favorecer la independencia y la participación, evitando limitar innecesariamente la movilidad. Para ello, es importante observar cómo la persona se desplaza, utiliza los espacios y realiza sus actividades cotidianas.

6.1. Tipos de ambientes y condiciones del entorno domiciliario

La persona mayor puede desarrollar sus actividades en diferentes espacios del hogar, como la sala, el dormitorio, el baño, la cocina, los pasillos, las escaleras y las zonas de acceso. Cada uno presenta características y riesgos particulares que deben tenerse en cuenta durante el cuidado.

La valoración del entorno debe considerar tanto las condiciones físicas del espacio como las capacidades de la persona que lo utiliza. Algunos aspectos importantes son:

- **Zonas de circulación**: deben permanecer despejadas para facilitar el desplazamiento, especialmente cuando la persona utiliza bastón, caminador u otra ayuda técnica.
- **Iluminación**: debe ser suficiente, especialmente en pasillos, escaleras, entradas y zonas utilizadas durante la noche.
- **Pisos y superficies**: deben mantenerse secos, estables y libres de obstáculos que puedan provocar tropiezos o resbalones.
- **Accesibilidad**: los objetos de uso frecuente deben ubicarse en lugares de fácil alcance, evitando que la persona tenga que subir a superficies inestables o adoptar posiciones que puedan ocasionar una caída.
- **Mobiliario**: debe estar distribuido de manera que permita circular con facilidad y utilizar los espacios sin realizar movimientos innecesarios o inseguros.
- **Cables y objetos**: deben mantenerse organizados y fuera de las zonas de tránsito.
- **Temperatura y ventilación**: los espacios deben contar con condiciones ambientales confortables y una ventilación adecuada.

Prevención de caídas

Las caídas constituyen uno de los principales riesgos asociados al entorno de la persona mayor. Su prevención requiere considerar factores relacionados tanto con la persona como con el espacio en el que se desplaza.

Entre los factores relacionados con la persona pueden encontrarse la disminución de la fuerza muscular, las alteraciones del equilibrio, las dificultades visuales, algunas enfermedades y el uso de medicamentos que pueden producir mareo o somnolencia.

Entre los factores relacionados con el entorno se encuentran la iluminación insuficiente, superficies resbaladizas, obstáculos en las zonas de circulación, alfombras sueltas, cables expuestos y ausencia de apoyos en lugares como el baño o las escaleras.

Por esta razón, el cuidador debe revisar de manera permanente las condiciones del entorno y los cambios en la forma en que la persona mayor camina, se levanta, se sienta o utiliza los diferentes espacios. La identificación oportuna de estos cambios permite implementar medidas preventivas y favorecer un desplazamiento seguro.

6.2. Criterios de seguridad y adaptaciones básicas del hogar

La seguridad del entorno debe abordarse de manera integral. Además de prevenir caídas, es necesario identificar riesgos relacionados con instalaciones eléctricas, fuentes de calor, medicamentos, productos químicos, alimentos, agua y posibles situaciones de maltrato, negligencia o abandono.

Durante la revisión del hogar se deben considerar los siguientes criterios:

- Mantener instalaciones eléctricas seguras, sin cables expuestos ni conexiones improvisadas.
- Utilizar de manera segura las estufas, calentadores y otras fuentes de calor.
- Mantener medicamentos y productos químicos en lugares seguros, evitando su acceso accidental.
- Organizar y rotular adecuadamente los medicamentos para disminuir el riesgo de errores.
- Mantener disponibles agua potable y alimentos en condiciones higiénicas adecuadas.

- Conservar libres de obstáculos las zonas de circulación.
- Disponer de elementos de apoyo cuando las necesidades de la persona lo requieran.
- Observar cambios en el comportamiento, el estado emocional o las condiciones de cuidado que puedan indicar situaciones de maltrato, negligencia o abandono.

La seguridad debe revisarse periódicamente, ya que las necesidades de la persona mayor pueden cambiar con el tiempo. Una modificación en su movilidad, equilibrio, visión, estado de salud o capacidad para realizar actividades cotidianas puede requerir nuevos ajustes en el entorno. Por ello, cuando se identifican condiciones que pueden representar un riesgo o dificultar el desarrollo de las actividades cotidianas, es necesario considerar adaptaciones que permitan hacer del hogar un espacio más seguro y accesible.

Las adaptaciones del hogar buscan reducir riesgos, facilitar la movilidad y favorecer la autonomía. Deben realizarse de acuerdo con las necesidades reales de la persona, evitando modificaciones innecesarias y procurando que pueda desenvolverse de manera segura en las actividades de la vida diaria.

Entre las adaptaciones que pueden considerarse se encuentran:

Tabla 6. Adaptaciones básicas

Espacio	Adaptaciones básicas
Pasillos y zonas de circulación	Mantener espacios despejados, retirar alfombras sueltas y eliminar obstáculos o desniveles que dificulten el desplazamiento.
Escaleras	Disponer de pasamanos firmes y mantener los escalones libres de objetos, con iluminación suficiente.
Baño	Instalar barras de apoyo cerca del sanitario y en la ducha, utilizar superficies antideslizantes y considerar una silla de baño cuando sea necesario.
Dormitorio	Mantener la cama a una altura adecuada, disponer de iluminación cercana y ubicar los objetos de uso frecuente al alcance de la persona.
Cocina	Organizar los utensilios y alimentos de uso frecuente en lugares accesibles, evitando que la persona deba agacharse excesivamente o subirse a superficies inestables.

Estas adaptaciones deben facilitar las actividades cotidianas sin sustituir innecesariamente la participación de la persona mayor. El propósito es proporcionar un entorno que permita realizar las actividades de manera segura, accesible y acorde con sus capacidades.

El cuidador debe identificar los riesgos que pueda observar durante las actividades cotidianas, informar oportunamente las condiciones que requieran intervención y apoyar la implementación de las medidas de seguridad correspondientes.

7. Bioseguridad en el cuidado

La bioseguridad comprende el conjunto de medidas orientadas a prevenir la exposición y transmisión de agentes infecciosos durante las actividades de cuidado y a proteger tanto a la persona mayor como al cuidador.

En el cuidado domiciliario o institucional, estas medidas deben aplicarse de manera constante, especialmente cuando existe contacto con sangre, secreciones, excreciones, mucosas, piel lesionada, objetos contaminados o superficies que puedan contener microorganismos.

La bioseguridad no se limita al uso de elementos de protección personal. También incluye la higiene de manos, la limpieza y desinfección, el manejo seguro de residuos, el uso adecuado de barreras de protección y la identificación de los riesgos presentes durante cada actividad.

7.1. Objetivos y principios de bioseguridad

La bioseguridad comprende las medidas y prácticas que permiten prevenir riesgos para la salud durante las actividades de cuidado. Su aplicación busca proteger a la persona mayor, al cuidador y a otras personas del entorno frente a la posible exposición a microorganismos y sustancias que puedan causar daño.

En el cuidado cotidiano, la bioseguridad tiene como objetivos:

- Prevenir la transmisión de infecciones durante las actividades de cuidado.
- Reducir el riesgo de exposición a sangre, secreciones, excreciones y otros fluidos corporales.

- Mantener condiciones adecuadas de higiene y limpieza en el entorno y los elementos utilizados.
- Promover prácticas seguras en la manipulación de residuos, ropa y materiales.
- Proteger tanto a la persona mayor como al cuidador durante las actividades que impliquen algún riesgo de contaminación.

Para cumplir estos objetivos, la bioseguridad se fundamenta en principios que orientan la actuación del cuidador.

- **Universalidad**: las medidas básicas de protección deben aplicarse de manera habitual, independientemente de que la persona mayor tenga o no una infección identificada. Esto permite prevenir la exposición a microorganismos que pueden estar presentes sin ser visibles.
- **Prevención**: antes de realizar una actividad, el cuidador debe identificar los posibles riesgos y adoptar las medidas necesarias para reducirlos. La prevención implica preparar el espacio, disponer de los materiales requeridos y utilizar las medidas de protección que correspondan.
- **Barreras de protección**: los elementos de protección personal funcionan como una barrera entre el cuidador y las posibles fuentes de contaminación. Su utilización depende del tipo de actividad y del riesgo de exposición.
- **Higiene**: la higiene de manos, la limpieza del entorno y el manejo adecuado de los elementos utilizados durante el cuidado son acciones fundamentales para reducir la transmisión de microorganismos.

- **Manejo seguro de materiales y residuos**: los materiales que hayan estado en contacto con fluidos corporales deben manipularse de manera que se evite la contaminación de las manos, la ropa, las superficies y otras personas.

La aplicación de estos principios debe realizarse de manera constante y de acuerdo con el riesgo presente en cada actividad. La bioseguridad no consiste únicamente en utilizar elementos de protección personal; también requiere mantener hábitos de higiene, reconocer situaciones de riesgo y actuar de manera preventiva.

7.2. Precauciones universales y elementos de protección personal

Las precauciones universales son un conjunto de medidas que deben aplicarse durante las actividades de cuidado para disminuir el riesgo de exposición a microorganismos y prevenir la transmisión de infecciones. Se utilizan independientemente de que la persona mayor tenga o no una infección identificada, ya que algunos agentes pueden estar presentes sin que exista un diagnóstico confirmado.

Estas medidas deben incorporarse de manera habitual en las actividades de cuidado y adaptarse al riesgo presente. Entre las principales se encuentran:

- Realizar higiene de manos antes y después del contacto con la persona mayor, antes de manipular alimentos o medicamentos y después de actividades de higiene o eliminación.
- Utilizar guantes cuando exista posibilidad de contacto con sangre, orina, heces, saliva, secreciones, mucosas o heridas.

- Utilizar mascarilla o tapabocas cuando exista riesgo de transmisión respiratoria, de acuerdo con la situación presentada.
- Proteger la ropa y el cuerpo cuando exista riesgo de contacto o salpicadura de fluidos.
- Utilizar protección ocular cuando puedan producirse salpicaduras que alcancen los ojos.
- Manipular de forma segura la ropa, los materiales y los residuos que hayan estado en contacto con fluidos corporales, evitando acciones que puedan dispersar microorganismos.
- Mantener limpios y desinfectados los objetos y superficies de contacto frecuente, según corresponda.

Los elementos de protección personal (EPP) son dispositivos que actúan como barreras físicas para disminuir la exposición a agentes biológicos durante determinadas actividades de cuidado. Su utilización debe responder al riesgo identificado, por lo que no todas las actividades requieren los mismos elementos.

Tabla 7. Elementos de protección personal según el riesgo durante el cuidado

Elemento de protección	**¿Cuándo utilizarlo?**
Guantes desechables	Cuando exista riesgo de contacto con sangre, orina, heces, saliva, secreciones, mucosas o heridas abiertas.
Mascarilla o tapabocas	Cuando exista riesgo de exposición a secreciones respiratorias o durante situaciones que impliquen

Elemento de protección	¿Cuándo utilizarlo?
	contacto cercano con una persona con síntomas respiratorios.
Delantal o protector corporal	Cuando exista riesgo de salpicaduras o contacto con una cantidad considerable de fluidos, por ejemplo, durante el baño asistido o el cambio de apósitos.
Gafas de protección o careta facial	Cuando exista riesgo de salpicaduras que puedan entrar en contacto con los ojos, como durante algunas actividades de curación o manejo de secreciones.

La elección de los EPP debe considerar el tipo de actividad, el posible contacto con fluidos y las condiciones particulares de la situación. Su uso debe ser proporcional al riesgo: emplear protección cuando sea necesaria, sin convertirla en un sustituto de las medidas básicas de higiene.

Es importante recordar que los EPP complementan, pero no reemplazan, la higiene de manos ni las demás medidas de bioseguridad. Además, deben utilizarse, retirarse, desecharse, limpiarse o almacenarse de manera adecuada, según se trate de elementos desechables o reutilizables.

En el cuidado de la persona mayor, la bioseguridad debe integrarse a las actividades cotidianas sin perder de vista el trato digno, la comodidad y la participación de la persona. El cuidador debe identificar los riesgos, aplicar las medidas correspondientes y comunicar cualquier situación que requiera atención profesional.

8. Higiene y cuidado cefalocaudal

La higiene corporal de la persona mayor contribuye a mantener la limpieza, proteger la integridad de la piel, prevenir infecciones y favorecer el bienestar y la comodidad. Además, constituye una oportunidad para observar el estado general de la persona e identificar cambios que puedan requerir atención.

El cuidado cefalocaudal consiste en realizar la higiene corporal siguiendo un orden organizado, desde la cabeza hacia los pies. Esta secuencia facilita el desarrollo sistemático del procedimiento, evita omisiones y contribuye a disminuir el riesgo de contaminación cruzada.

Durante este cuidado es fundamental respetar la privacidad, la dignidad y las capacidades de la persona mayor, promoviendo su participación en aquellas actividades que pueda realizar por sí misma.

8.1. Objetivos

El cuidado cefalocaudal tiene como propósito mantener una adecuada higiene corporal y contribuir al bienestar integral de la persona mayor. Además de favorecer la limpieza, este procedimiento permite observar el estado de la piel y reconocer oportunamente cambios que puedan afectar su salud o funcionalidad.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

- Mantener la higiene corporal y reducir la acumulación de suciedad y microorganismos en la superficie de la piel.

- Preservar la integridad de la piel, disminuyendo el riesgo de irritaciones, lesiones asociadas a la humedad y otros problemas cutáneos.
- Prevenir infecciones, mediante una adecuada higiene corporal y la aplicación de prácticas seguras durante el procedimiento.
- Favorecer la comodidad y el bienestar físico y emocional de la persona mayor.
- Promover la participación y autonomía, permitiendo que la persona realice las actividades que pueda desarrollar de acuerdo con sus capacidades.
- Identificar cambios en la piel, como enrojecimientos, lesiones, alteraciones de coloración o signos que requieran ser comunicados.
- Fortalecer un cuidado respetuoso y humanizado, protegiendo la privacidad, dignidad y preferencias de la persona mayor.

De esta manera, la higiene corporal no debe entenderse únicamente como una actividad de limpieza, sino también como una oportunidad para observar, prevenir riesgos y favorecer la autonomía y el bienestar de la persona mayor.

8.2. Procedimiento básico

El cuidado cefalocaudal debe realizarse de manera organizada, sistemática y respetuosa, siguiendo una secuencia desde la cabeza hasta los pies. Antes de comenzar, es necesario preparar el entorno, disponer de los materiales y valorar las condiciones de la persona mayor. Durante todo el procedimiento se debe favorecer su participación de acuerdo con el nivel de autonomía y mantener una comunicación respetuosa.

a) **Antes de iniciar el procedimiento**

- Garantizar la privacidad de la persona mayor y mantener una temperatura confortable y una iluminación adecuada.
- Reunir los materiales necesarios: agua tibia, jabón neutro, toallas limpias, ropa limpia, hidratante y los elementos de protección personal que correspondan.
- Realizar la higiene de manos y utilizar los elementos de protección personal de acuerdo con el riesgo identificado.
- Explicar a la persona mayor qué se va a realizar y promover su participación según sus capacidades.
- Verificar las condiciones de movilidad y colaboración, así como la presencia de lesiones, zonas de presión o dispositivos médicos que deban tenerse en cuenta durante la higiene.

b) **La higiene se realiza siguiendo el orden cefalocaudal, avanzando de la cabeza hacia los pies**

- Cabeza y rostro: realizar la limpieza de manera suave, incluyendo rostro y cuello. Los ojos deben limpiarse cuidadosamente, evitando la fricción excesiva.
- Miembros superiores: limpiar hombros, brazos, manos y espacios entre los dedos. Secar cuidadosamente para evitar humedad residual.
- Tórax y abdomen: realizar la limpieza con movimientos suaves, prestando especial atención a los pliegues de la piel.

- Miembros inferiores: limpiar desde los muslos hasta los pies, incluyendo talones y espacios entre los dedos.
- Zona genital y perineal: realizar la higiene al final, con el propósito de disminuir el riesgo de contaminación cruzada.

c) **Una vez realizada la higiene, se debe secar completamente la piel, especialmente en los pliegues, para evitar la acumulación de humedad. Cuando esté indicado, puede aplicarse crema hidratante mediante un masaje suave, evitando las zonas enrojecidas o lesionadas.**

Posteriormente

- Colocar ropa limpia y cómoda.
- Verificar que la persona mayor quede en una posición segura y confortable.
- Organizar el entorno y retirar los materiales utilizados.
- Desechar, limpiar o desinfectar los elementos empleados según corresponda.
- Realizar nuevamente la higiene de manos.
- Registrar los hallazgos relevantes cuando se requiera seguimiento.

Durante todo el procedimiento, se debe observar el estado general de la persona mayor y comunicar oportunamente cualquier cambio o hallazgo que pueda requerir valoración por parte de un profesional de salud.

8.3. Precauciones

Durante el cuidado cefalocaudal es necesario adoptar medidas que permitan realizar la higiene de manera segura, respetuosa y acorde con las condiciones de la persona mayor. Las precauciones deben considerar tanto la seguridad física como la protección de la piel, la prevención de infecciones y el bienestar de la persona.

- **Proteger la privacidad y dignidad**: mantener cubierta la parte del cuerpo que no se esté aseando, explicar cada acción y respetar las preferencias de la persona mayor.
- **Evitar riesgos de caídas**: mantener el espacio libre de obstáculos, asegurar una superficie estable y no dejar sola a la persona cuando requiera asistencia para movilizarse.
- **Controlar la temperatura del agua**: utilizar agua tibia y comprobar que sea adecuada antes de entrar en contacto con la piel.
- **Prevenir lesiones**: realizar movimientos suaves y evitar fricciones excesivas, especialmente en personas con piel frágil, dolor o limitaciones de movilidad.
- **Proteger la integridad de la piel**: prestar especial atención a pliegues, zonas de presión, enrojecimientos, heridas o áreas con humedad.
- **Aplicar medidas de bioseguridad**: realizar higiene de manos, utilizar los elementos de protección personal cuando exista riesgo de exposición y emplear materiales limpios.
- **Evitar la contaminación cruzada**: respetar la secuencia cefalocaudal, utilizar materiales adecuados y realizar la higiene de las zonas con mayor riesgo de contaminación al final.

- **Tener precaución con dispositivos médicos**: evitar movimientos o manipulaciones que puedan desplazarlos o afectar su funcionamiento.
- **Promover la participación**: permitir que la persona mayor realice por sí misma las actividades que pueda desarrollar, brindando únicamente el apoyo que necesite.
- **Revisar el estado general**: prestar atención a cambios en la piel, dolor, mareo, fatiga, dificultad respiratoria u otras alteraciones durante el procedimiento y comunicar los hallazgos relevantes.

Si durante la higiene se presenta malestar, mareo, fatiga, dolor intenso o dificultad respiratoria, se debe suspender el procedimiento y valorar la situación antes de continuar.

9. Lavado de manos

El lavado de manos es una medida fundamental para prevenir la transmisión de microorganismos durante las actividades de cuidado. Las manos pueden entrar en contacto con personas, superficies, objetos y diferentes materiales, por lo que una higiene adecuada permite reducir la posibilidad de llevar microorganismos de un lugar a otro.

En el cuidado de la persona mayor, la higiene de manos debe incorporarse de manera habitual antes, durante y después de determinadas actividades, especialmente cuando existe contacto directo con la persona, sus pertenencias, alimentos, medicamentos, secreciones o elementos utilizados durante la higiene. La aplicación correcta de esta medida contribuye a proteger tanto a la persona mayor como al cuidador.

9.1. Importancia

La higiene de manos es una de las medidas más importantes para interrumpir la transmisión de microorganismos. Su importancia radica en que permite eliminar o reducir la contaminación presente en las manos y disminuir el riesgo de transmitir agentes infecciosos durante las actividades cotidianas de cuidado.

Su aplicación adecuada permite:

- Prevenir la transmisión de infecciones entre el cuidador, la persona mayor y el entorno.
- Reducir la contaminación de objetos, alimentos, medicamentos y superficies.

- Proteger a la persona mayor durante actividades que requieren contacto directo.
- Proteger al cuidador frente a microorganismos presentes en el entorno o en materiales potencialmente contaminados.
- Complementar las demás medidas de bioseguridad, como el uso de elementos de protección personal y la limpieza del entorno.

En el cuidado cotidiano, la higiene de manos debe realizarse, entre otros momentos, antes y después del contacto con la persona mayor, antes de manipular alimentos o medicamentos y después de realizar actividades de higiene o eliminación.

No basta con realizar el lavado de manera rápida; es necesario aplicar una técnica que permita limpiar todas las superficies de las manos, incluyendo palmas, dorsos, espacios entre los dedos, pulgares, puntas de los dedos y uñas.

9.2. Técnicas y elementos necesarios

La higiene de manos puede realizarse mediante lavado con agua y jabón o, cuando las condiciones lo permitan, mediante una preparación a base de alcohol. La elección depende de la situación y de las condiciones de las manos.

Para el lavado con agua y jabón se requieren:

- Agua.
- Jabón.
- Toalla limpia o medio adecuado para el secado.
- Recipiente para residuos, cuando corresponda.

La técnica debe realizarse de manera ordenada:

a) Mojar las manos con agua.
b) Aplicar jabón suficiente para cubrir todas las superficies.
c) Frotar las palmas entre sí.
d) Frotar el dorso de cada mano con la palma de la mano contraria.
e) Limpiar los espacios entre los dedos, entrelazándolos.
f) Frotar los pulgares mediante movimientos rotatorios.
g) Frotar las puntas de los dedos y las uñas sobre la palma de la mano contraria.
h) Enjuagar completamente con agua.
i) Secar las manos con una toalla limpia o un medio adecuado.
j) Evitar volver a contaminar las manos al finalizar, por ejemplo, mediante el contacto innecesario con superficies contaminadas.

Para complementar los pasos descritos y facilitar la comprensión de la técnica, acceda al siguiente video, en el que se presenta de manera gráfica la secuencia adecuada para el lavado de manos: https://www.youtube.com/watch?v=N5iWzjNWh8A

Cuando se utiliza una preparación a base de alcohol, se debe aplicar una cantidad suficiente para cubrir todas las superficies de las manos y frotarlas hasta que estén secas.

La técnica debe realizarse con especial cuidado cuando las manos estén visiblemente sucias o después de actividades que impliquen contacto con sustancias, secreciones o residuos. En estas situaciones, el lavado con agua y jabón resulta fundamental.

El uso de guantes no elimina la necesidad de realizar higiene de manos. Los guantes son una medida complementaria y deben utilizarse de acuerdo con el riesgo identificado durante la actividad de cuidado.

10. Autocuidado y bienestar

El autocuidado hace referencia a las acciones y decisiones que contribuyen al mantenimiento de la salud, la funcionalidad y el bienestar, de acuerdo con las capacidades y condiciones de cada persona. En la persona mayor, promover el autocuidado implica reconocer las capacidades que conserva, favorecer su participación en las actividades cotidianas y proporcionar el apoyo necesario sin sustituir de manera innecesaria aquello que puede realizar por sí misma.

El bienestar comprende diferentes dimensiones que se relacionan entre sí. Además de atender las necesidades físicas, el cuidado debe considerar los aspectos emocionales, sociales y relacionados con la autonomía y la participación. Mantener vínculos significativos, participar en actividades acordes con las capacidades y tomar decisiones sobre aspectos de la vida cotidiana contribuye a preservar la autoestima, la funcionalidad y la calidad de vida.

10.1. Autocuidado y autonomía de la persona mayor

El autocuidado se relaciona directamente con la conservación de la autonomía. Por ello, las actividades de cuidado deben orientarse a hacer con la persona y no simplemente hacer por ella, siempre que sus condiciones lo permitan.

En las actividades de la vida cotidiana, el cuidador debe identificar qué puede realizar la persona mayor de manera independiente, en qué actividades requiere supervisión y en cuáles necesita asistencia parcial o total. De esta manera, el apoyo se ajusta al nivel de dependencia y se evita la sobreprotección.

El autocuidado puede favorecerse mediante acciones como:

- Participar en la higiene personal y el arreglo.
- Colaborar en la alimentación y la hidratación según sus capacidades.
- Realizar movimientos y actividades físicas acordes con su condición.
- Elegir entre diferentes opciones relacionadas con su rutina y cuidado.
- Participar en actividades recreativas, culturales y sociales.
- Mantener relaciones con familiares, amigos y otras personas significativas.
- Expresar necesidades, preferencias, emociones y decisiones.
- Conservar hábitos de descanso y sueño adecuados.

La participación en estas actividades permite mantener habilidades y puede contribuir a prevenir la pérdida innecesaria de funcionalidad y el aislamiento social.

10.2. Bienestar de la persona mayor y autocuidado del cuidador

El bienestar de la persona mayor no depende únicamente de la ausencia de enfermedad. También está relacionado con la posibilidad de sentirse respetada, escuchada, segura y partícipe de las decisiones que afectan su vida. Por esta razón, el cuidado debe favorecer espacios de comunicación, acompañamiento y participación social, de acuerdo con sus intereses y capacidades.

El cuidador puede contribuir al bienestar mediante un trato respetuoso, la escucha activa, el reconocimiento de las preferencias de la persona y la promoción de actividades que resulten significativas. También debe evitar el aislamiento y procurar que la persona mantenga, cuando sea posible, sus vínculos familiares, sociales y

comunitarios. Estas dimensiones hacen parte de las necesidades integrales que deben considerarse en el proceso de cuidado.

El autocuidado también es necesario para quien cuida. Las actividades de cuidado pueden implicar esfuerzo físico, emocional y organización del tiempo. Por ello, el cuidador debe reconocer sus propios límites y mantener prácticas que favorezcan su bienestar, entre ellas:

- Mantener una alimentación e hidratación adecuadas.
- Procurar períodos suficientes de descanso y sueño.
- Realizar actividad física de acuerdo con sus posibilidades.
- Organizar las actividades de cuidado y establecer prioridades.
- Reconocer signos de cansancio físico o emocional.
- Buscar apoyo de familiares, redes sociales o servicios disponibles cuando la situación lo requiera.
- Conservar espacios para actividades personales, recreativas y sociales.
- Solicitar orientación cuando una situación de cuidado supere sus conocimientos o capacidades.

El autocuidado del cuidador contribuye a mantener condiciones adecuadas para brindar una atención segura y de calidad. A su vez, reconocer los propios límites permite solicitar apoyo oportunamente y evitar que las responsabilidades de cuidado se desarrollen de manera inadecuada.

En síntesis, promover el autocuidado y el bienestar significa equilibrar la asistencia con la autonomía. El cuidador debe proporcionar el apoyo que la persona mayor necesita, pero también crear las condiciones para que continúe participando en

las actividades que puede realizar, tome decisiones y conserve sus capacidades durante el mayor tiempo posible.

11. Nutrición y asistencia en la alimentación

La alimentación es un componente fundamental del cuidado integral de la persona mayor, ya que proporciona la energía y los nutrientes necesarios para mantener las funciones del organismo, conservar la masa muscular, favorecer la capacidad funcional y contribuir al bienestar general. Una alimentación adecuada también participa en la prevención de deficiencias nutricionales y en el mantenimiento de condiciones que favorecen una vida activa y autónoma.

Durante el envejecimiento pueden presentarse cambios que influyen en la alimentación, como disminución del apetito, modificaciones en la percepción del gusto y el olfato, problemas de salud oral, dificultades para masticar o deglutir y cambios en el funcionamiento del sistema digestivo. También puede disminuir la sensación de sed, lo que aumenta el riesgo de una ingesta insuficiente de líquidos. Estas condiciones deben ser reconocidas durante el cuidado para brindar un apoyo adecuado y prevenir complicaciones.

La alimentación de la persona mayor debe responder a sus necesidades individuales y considerar aspectos como su estado de salud, nivel de actividad, capacidades funcionales, hábitos alimentarios, preferencias culturales y capacidad para masticar y deglutir. Por ello, no existe una única alimentación que pueda aplicarse de la misma manera a todas las personas mayores.

En este contexto, el cuidador cumple una función de apoyo que comprende la preparación y disposición adecuada de los alimentos, el acompañamiento durante la ingesta y la observación de posibles dificultades. La asistencia debe ajustarse al nivel de dependencia, promoviendo que la persona participe en las acciones que puede realizar por sí misma y evitando sustituir innecesariamente sus capacidades.

Cuando existen condiciones particulares de salud, restricciones alimentarias o dificultades para la deglución, las orientaciones establecidas por los profesionales de salud deben ser respetadas. El cuidador no debe modificar por iniciativa propia la dieta, las consistencias de los alimentos ni las fórmulas nutricionales prescritas.

A lo largo de este tema se abordarán los principales nutrientes y grupos de alimentos, las características de una alimentación equilibrada, la identificación de posibles deficiencias nutricionales, el uso de fórmulas nutricionales bajo indicación profesional, las técnicas básicas de preparación de alimentos y las formas de asistencia durante la alimentación, especialmente cuando existen dificultades para deglutir o limitaciones de movilidad.

11.1. Nutrición, nutrientes y grupos de alimentos

La nutrición es un proceso mediante el cual el organismo obtiene y utiliza los nutrientes necesarios para mantener sus funciones, producir energía, conservar los tejidos y contribuir al bienestar. En la persona mayor, una alimentación adecuada favorece el mantenimiento de la masa muscular, la capacidad funcional y la salud general.

Durante el envejecimiento pueden presentarse cambios que influyen en la alimentación, como modificaciones en el apetito, el gusto y el olfato, dificultades para masticar o deglutir y cambios en la percepción de la sed. Por esta razón, es importante reconocer los alimentos y nutrientes que contribuyen a cubrir las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta sus condiciones individuales.

Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son necesarios en cantidades mayores y comprenden los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los micronutrientes se requieren en cantidades menores e incluyen las vitaminas y los minerales.

Tabla 8. Principales nutrientes y sus funciones

Nutriente	Función principal	Fuentes alimentarias
Carbohidratos	Aportan energía para las actividades del organismo.	Cereales, arroz, avena, papa, yuca, plátano, frutas y otros alimentos de origen vegetal.
Proteínas	Contribuyen al mantenimiento y reparación de los tejidos y de la masa muscular.	Legumbres, huevos, pescado, pollo, carnes y productos lácteos.
Grasas	Aportan energía y participan en la absorción de algunas vitaminas.	Aceites vegetales, aguacate, frutos secos, semillas y otros alimentos que contienen grasas.
Vitaminas	Participan en diferentes procesos del organismo y contribuyen al mantenimiento de sus funciones.	Frutas, verduras, legumbres, cereales, huevos, carnes y otros alimentos.

Nutriente	Función principal	Fuentes alimentarias
Minerales	Intervienen en funciones como la formación de huesos, el funcionamiento muscular y otros procesos del organismo.	Lácteos, verduras, frutas, legumbres, carnes, pescado y otros alimentos.

Además de los nutrientes, es necesario considerar el agua como un componente fundamental de la alimentación. Contribuye a mantener la hidratación y participa en diferentes funciones del organismo. En las personas mayores es importante prestar atención a la ingesta de líquidos, debido a que la sensación de sed puede disminuir con la edad.

Los alimentos pueden organizarse en diferentes grupos de acuerdo con sus características y principales aportes nutricionales. Una alimentación adecuada combina alimentos de los distintos grupos y se adapta a las necesidades, condiciones de salud, preferencias y posibilidades de cada persona.

Tabla 9. Grupos de alimentos y principales aportes

Grupo de alimentos	Principales aportes	Ejemplos
Frutas y verduras	Vitaminas, minerales, fibra y agua.	Papaya, naranja, mango, manzana, zanahoria, tomate, espinaca y brócoli.

Grupo de alimentos	Principales aportes	Ejemplos
Legumbres y alimentos proteicos	Proteínas, minerales y otros nutrientes necesarios para el mantenimiento de los tejidos.	Lentejas, fríjoles, garbanzos, huevos, pescado, pollo y carnes.
Cereales, tubérculos y plátanos	Principalmente carbohidratos y energía.	Arroz, avena, maíz, pan, papa, yuca, ñame y plátano.
Leche y productos lácteos	Proteínas y calcio, entre otros nutrientes.	Leche, yogur y queso.
Grasas y aceites	Aportan energía y grasas necesarias para diferentes funciones del organismo.	Aceite vegetal, aguacate, frutos secos y semillas.

La selección y combinación de estos alimentos debe considerar las características de cada persona mayor. Aspectos como el estado de salud, el nivel de actividad física, los hábitos alimentarios, las preferencias culturales, la disponibilidad de alimentos y la capacidad para masticar y deglutir pueden influir en la alimentación.

En el cuidado cotidiano, el cuidador puede contribuir a disponer los alimentos de manera adecuada, favorecer una alimentación variada y apoyar a la persona mayor durante las actividades relacionadas con la alimentación, de acuerdo con su nivel de autonomía. Cuando existen restricciones alimentarias o indicaciones específicas

relacionadas con alguna condición de salud, estas deben seguirse conforme a las orientaciones establecidas por los profesionales correspondientes.

11.2. Dieta balanceada

Una dieta balanceada proporciona al organismo una variedad de alimentos y nutrientes en cantidades adecuadas para contribuir al mantenimiento de la salud, la funcionalidad y el bienestar. En la persona mayor, la alimentación debe adaptarse a sus características individuales, teniendo en cuenta su estado de salud, nivel de actividad, necesidades nutricionales, hábitos alimentarios, preferencias y capacidad para masticar y deglutir.

Una alimentación adecuada no consiste únicamente en consumir alimentos de todos los grupos, sino también en establecer combinaciones y preparaciones que respondan a las necesidades de cada persona. Por ello, la alimentación puede requerir ajustes cuando existen enfermedades, restricciones alimentarias o dificultades para realizar alguna actividad relacionada con la ingesta.

Entre las características de una dieta balanceada se encuentran:

a) **Variedad**: incluir alimentos de diferentes grupos para favorecer el aporte de diversos nutrientes.
b) **Equilibrio**: mantener una combinación adecuada de los diferentes grupos de alimentos, evitando que la alimentación se base principalmente en un solo tipo de alimento.
c) **Suficiencia**: proporcionar la cantidad de energía y nutrientes necesaria de acuerdo con las condiciones de cada persona.

d) **Adecuación**: considerar la edad, el estado de salud, el nivel de actividad, las capacidades funcionales y las necesidades particulares.
e) **Hidratación**: favorecer un consumo adecuado de líquidos, teniendo en cuenta las indicaciones establecidas cuando existen restricciones.
f) **Aceptabilidad**: considerar los gustos, costumbres, cultura y posibilidades de acceso a los alimentos.

En la alimentación de la persona mayor se pueden combinar frutas y verduras, alimentos fuente de proteínas, cereales, tubérculos y plátanos, productos lácteos o sus alternativas, y fuentes de grasas, procurando variedad y equilibrio. La selección de los alimentos debe ajustarse a las condiciones y necesidades de cada persona.

También es importante considerar la textura y consistencia de los alimentos. Cuando una persona presenta dificultades para masticar o deglutir, la preparación puede requerir modificaciones para facilitar la alimentación y disminuir riesgos. Estas modificaciones deben realizarse de acuerdo con las orientaciones de los profesionales responsables del cuidado.

La presentación y el ambiente durante la alimentación también pueden favorecer una experiencia agradable. Mantener una postura adecuada, disponer los alimentos de manera accesible y respetar el ritmo y las preferencias de la persona contribuye a su participación y autonomía.

En este proceso, el cuidador debe apoyar sin sustituir innecesariamente las capacidades de la persona mayor. Puede colaborar en la selección y preparación de los alimentos, disponerlos de manera adecuada, facilitar los elementos necesarios y acompañar durante la alimentación, de acuerdo con el nivel de dependencia.

Cuando existen enfermedades, restricciones alimentarias, pérdida importante de peso, disminución persistente del apetito u otras situaciones que puedan afectar el estado nutricional, es necesario comunicar los cambios y seguir las orientaciones de los profesionales de salud. El cuidador no debe establecer por cuenta propia dietas restrictivas ni modificar las indicaciones nutricionales.

Para tener en cuenta: una dieta balanceada no es igual para todas las personas mayores. Las necesidades y características individuales determinan los ajustes que pueden requerirse en la alimentación.

11.3. Deficiencia nutricional

La deficiencia nutricional se presenta cuando el organismo no recibe o no aprovecha adecuadamente la energía y los nutrientes que necesita para mantener sus funciones. En la persona mayor, esta situación puede relacionarse con una ingesta insuficiente de alimentos, cambios en el apetito, dificultades para masticar o deglutir, enfermedades, alteraciones en la absorción de nutrientes o condiciones que dificultan el acceso y consumo de alimentos.

La deficiencia nutricional puede afectar la capacidad funcional y el bienestar de la persona mayor. Cuando se mantiene durante un periodo prolongado, puede favorecer la pérdida de masa muscular, debilidad, fragilidad y mayor vulnerabilidad frente a enfermedades y otras complicaciones.

Durante las actividades de cuidado es importante prestar atención a cambios que puedan indicar que la persona no está cubriendo adecuadamente sus necesidades nutricionales. Algunas señales que pueden observarse son:

- Pérdida de peso no intencional.
- Disminución persistente del apetito o de la cantidad de alimentos consumidos.
- Debilidad generalizada y fatiga.
- Disminución de la masa muscular.
- Mayor dificultad para realizar actividades cotidianas.
- Fragilidad o aumento de la inestabilidad.
- Cambios en el estado de ánimo o en el estado cognitivo.
- Mayor susceptibilidad a infecciones.
- Heridas que presentan una cicatrización lenta.

Estas manifestaciones no permiten establecer por sí solas la presencia de una deficiencia nutricional, ya que pueden estar relacionadas con diferentes condiciones de salud. Sin embargo, su identificación oportuna permite comunicar los cambios y favorecer una valoración adecuada. Entre las manifestaciones señaladas en el material se encuentran la disminución de masa muscular, la fragilidad, la debilidad, la fatiga, la mayor susceptibilidad a infecciones y la cicatrización lenta de heridas.

Tabla 10. Signos de posible deficiencia nutricional y acciones del cuidador

Signo o cambio observado	Posible repercusión	Acción del cuidador
Pérdida de peso no intencional	Pérdida de masa muscular y deterioro funcional.	Registrar el cambio y comunicarlo al responsable del cuidado o

Signo o cambio observado	Posible repercusión	Acción del cuidador
		profesional correspondiente.
Disminución del apetito o de la ingesta	Menor aporte de energía y nutrientes.	Observar la alimentación y comunicar si la situación persiste.
Debilidad y fatiga	Mayor dificultad para realizar actividades cotidianas.	Brindar apoyo según el nivel de dependencia y comunicar el cambio.
Disminución de masa muscular	Pérdida de fuerza y capacidad funcional.	Favorecer la participación en las actividades que pueda realizar y comunicar los cambios.
Heridas con cicatrización lenta	Mayor riesgo de complicaciones.	Observar la evolución y comunicar la situación al profesional correspondiente.
Cambios en el estado de ánimo o cognitivo	Pueden afectar la alimentación y la participación en las actividades cotidianas.	Prestar atención a los cambios y comunicar su aparición o persistencia.

La prevención de la deficiencia nutricional requiere favorecer una alimentación adecuada, suficiente y equilibrada, de acuerdo con las necesidades individuales de la persona mayor. El cuidador puede contribuir mediante el acompañamiento durante las comidas, la preparación y disposición adecuada de los alimentos, la observación de la cantidad consumida y la identificación de dificultades que puedan afectar la alimentación.

Cuando se identifican cambios importantes o persistentes, es necesario comunicarlos al profesional correspondiente para que se determine si se requiere una valoración nutricional u otra intervención. El cuidador no debe indicar dietas, suplementos o cambios en la alimentación por iniciativa propia.

Para tener en cuenta: una persona puede presentar cambios en su peso, apetito o estado general por diferentes razones. Por ello, el papel del cuidador es observar, apoyar, registrar cuando corresponda y comunicar, no realizar diagnósticos.

11.4. Fórmulas nutricionales

Las fórmulas nutricionales son productos que aportan energía y nutrientes de manera concentrada. Pueden utilizarse como complemento de la alimentación habitual cuando la persona mayor no logra cubrir sus necesidades nutricionales mediante los alimentos, de acuerdo con la valoración y las indicaciones de los profesionales responsables.

En la persona mayor, pueden considerarse en situaciones como bajo peso, deficiencia nutricional o dificultad para cubrir los requerimientos de energía y

nutrientes mediante la alimentación habitual. Su uso debe responder a las necesidades particulares de cada persona.

Es importante tener en cuenta que las fórmulas nutricionales no son iguales para todas las personas. Su composición, cantidad y forma de utilización dependen de las necesidades identificadas y de las indicaciones establecidas.

Cuando una fórmula ha sido indicada, el cuidador debe:

- Verificar que corresponda al producto indicado.
- Respetar las cantidades y orientaciones establecidas.
- Mantener condiciones adecuadas de higiene durante su preparación y administración.
- Revisar las condiciones de conservación del producto.
- Observar la respuesta de la persona durante su consumo.
- Comunicar cualquier dificultad o cambio relevante.

El cuidador no debe seleccionar, modificar, suspender ni aumentar una fórmula nutricional por iniciativa propia. Estas decisiones corresponden a los profesionales responsables de la valoración nutricional.

Para tener en cuenta: las fórmulas nutricionales son un complemento de la alimentación cuando están indicadas. No deben administrarse de manera indiscriminada.

11.5. Técnicas de preparación de alimentos

La preparación de los alimentos debe contribuir a conservar su valor nutricional, facilitar su consumo y mantener condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En la persona mayor, también es importante considerar su capacidad para masticar y deglutir, así como las características de la alimentación establecida para cada persona.

La técnica de preparación se selecciona de acuerdo con el tipo de alimento y las necesidades de la persona mayor. Algunas técnicas permiten obtener preparaciones suaves y fáciles de consumir, mientras que otras ayudan a conservar las características de los alimentos.

Tabla 11. Técnicas básicas de preparación de alimentos

Técnica	Características	Ejemplos
Cocción al vapor	Cocina los alimentos mediante el vapor y ayuda a conservar sus características.	Verduras, pescado y algunos tubérculos.
Hervido	Cocina los alimentos en agua hasta alcanzar la textura deseada.	Verduras, tubérculos, cereales y legumbres.
Horneado o asado	Cocina los alimentos mediante calor, con poca o ninguna adición de grasa.	Carnes, pescado, verduras y tubérculos.

Técnica	Características	Ejemplos
Salteado	Cocina los alimentos rápidamente con una cantidad moderada de grasa.	Verduras, carnes y preparaciones combinadas.
Guisado o cocción lenta	Permite obtener preparaciones de textura suave mediante una cocción prolongada.	Carnes, legumbres, verduras y preparaciones mixtas.

Durante la preparación de los alimentos es importante tener en cuenta:

a) **Higiene y seguridad**: mantener limpias las manos, los utensilios y las superficies; separar los alimentos crudos de los cocidos y conservarlos en condiciones adecuadas.
b) **Textura y consistencia**: adaptar las preparaciones cuando la persona mayor presenta dificultades para masticar o deglutir, de acuerdo con las indicaciones establecidas por los profesionales responsables.
c) **Preferencias y hábitos**: considerar los gustos, costumbres y preparaciones conocidas por la persona mayor, siempre que sean compatibles con sus necesidades y orientaciones de alimentación.
d) **Presentación y temperatura**: procurar una presentación agradable y una temperatura adecuada para favorecer la aceptación y el consumo seguro de los alimentos.

e) **Vigilancia durante el cuidado**: prestar atención a las dificultades que puedan presentarse durante la preparación o el consumo de los alimentos y comunicarlas oportunamente.

Importante: las modificaciones en la textura, consistencia o características de la alimentación deben realizarse de acuerdo con las indicaciones establecidas para la persona. El cuidador no debe hacer cambios por iniciativa propia.

11.6. Asistencia en la alimentación

La asistencia durante la alimentación busca facilitar que la persona mayor consuma los alimentos de manera segura, cómoda y respetuosa, de acuerdo con sus capacidades y nivel de dependencia. El apoyo debe permitir que la persona participe en las acciones que pueda realizar por sí misma, evitando sustituir innecesariamente sus capacidades.

Antes de iniciar la alimentación, es importante:

- Verificar que la persona se encuentre en condiciones adecuadas para alimentarse.
- Ubicarla en una posición cómoda y segura.
- Disponer los alimentos y utensilios a una altura que facilite su acceso.
- Comprobar que la preparación corresponda a las características de alimentación establecidas.
- Explicar lo que se va a realizar y favorecer la participación de la persona.

a) **Cuando existe dificultad para deglutir**: las dificultades para deglutir pueden aumentar el riesgo de que los alimentos o líquidos ingresen a las vías respiratorias. Por ello, la asistencia debe realizarse con especial cuidado y siguiendo las indicaciones establecidas para la persona. Durante la alimentación:

- Mantener a la persona en una posición incorporada y estable.
- Ofrecer cantidades pequeñas de alimento y permitir que complete la deglución antes de ofrecer una nueva porción.
- Respetar el ritmo de la persona y evitar apresurarla.
- Mantener atención a posibles cambios durante la alimentación.
- Utilizar la consistencia de alimentos y líquidos indicada para la persona.
- Después de finalizar, mantener una posición incorporada durante un periodo adecuado, de acuerdo con las indicaciones establecidas.

Algunas señales que requieren atención durante o después de la alimentación son:

- Tos persistente.
- Cambios en la voz después de comer o beber.
- Dificultad para respirar.
- Dificultad evidente para completar la deglución.
- Cambios importantes en el estado general.

Ante estas situaciones, se debe actuar de acuerdo con los protocolos establecidos y comunicar oportunamente al profesional correspondiente.

b) **Cuando existe movilidad reducida**: las limitaciones de movilidad pueden dificultar que la persona tome los alimentos, utilice los utensilios o mantenga una postura adecuada. En estos casos, la asistencia debe orientarse a facilitar la actividad sin reemplazar las capacidades que aún conserva. Para favorecer su participación se pueden considerar:

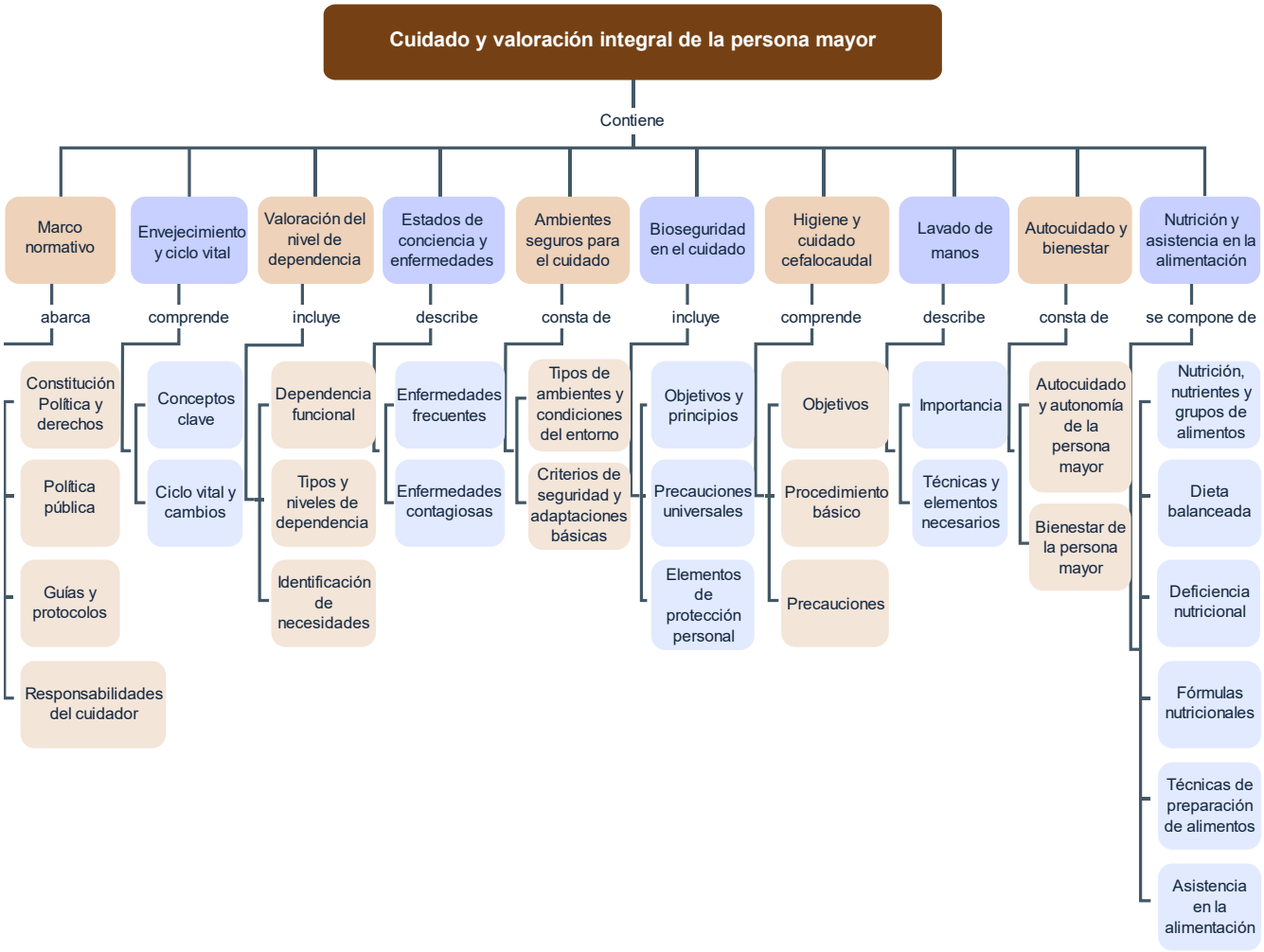
- Ubicar los alimentos y utensilios al alcance de la persona.
- Utilizar utensilios adaptados, cuando estén indicados, como cubiertos con mangos gruesos, platos antideslizantes o vasos con tapa.
- Facilitar una postura estable y cómoda.
- Permitir que la persona realice las acciones que pueda ejecutar por sí misma.
- Brindar ayuda únicamente en las acciones que requieran apoyo.
- Respetar el ritmo de alimentación y evitar apresurar el proceso.

La asistencia en la alimentación debe combinar seguridad, comodidad y autonomía. El cuidador debe revisar las capacidades de la persona, proporcionar el apoyo necesario y comunicar cualquier dificultad que pueda afectar su alimentación.

Importante: las modificaciones en la consistencia de los alimentos o líquidos, así como otras medidas específicas para las dificultades de deglución, deben seguir las indicaciones de los profesionales responsables. El cuidador no debe establecer estos cambios por iniciativa propia.

Síntesis

El componente formativo aborda los aspectos fundamentales para el cuidado integral de la persona mayor, incluyendo el marco normativo y los derechos, el proceso de envejecimiento, la valoración del nivel de dependencia, el reconocimiento de enfermedades frecuentes y contagiosas, la prevención de riesgos y la adecuación de ambientes seguros. Asimismo, desarrolla medidas de bioseguridad, higiene y cuidado cefalocaudal, promoción del autocuidado y bienestar, nutrición, preparación de alimentos y asistencia durante la alimentación, con el propósito de fortalecer conocimientos y habilidades para brindar un cuidado seguro, humanizado y centrado en las capacidades, necesidades, autonomía y dignidad de la persona mayor.


Cuidado y valoración integral de la persona mayor
Contiene
Marco normativo
Envejecimiento y ciclo vital
Valoración del nivel de dependencia
Estados de conciencia y enfermedades
Ambientes seguros para el cuidado
Bioseguridad en el cuidado
Higiene y cuidado cefalocaudal
Lavado de manos
Autocuidado y bienestar
Nutrición y asistencia en la alimentación
abarca
comprende
incluye
describe
consta de
incluye
comprende
describe
consta de
se compone de
Constitución Política y derechos
Política pública
Guías y protocolos
Responsabilidades del cuidador
Conceptos clave
Ciclo vital y cambios
Dependencia funcional
Tipos y niveles de dependencia
Identificación de necesidades
Enfermedades frecuentes
Enfermedades contagiosas
Tipos de ambientes y condiciones del entorno
Criterios de seguridad y adaptaciones básicas
Objetivos y principios
Precauciones universales
Elementos de protección personal
Objetivos
Procedimiento básico
Precauciones
Importancia
Técnicas y elementos necesarios
Autocuidado y autonomía de la persona mayor
Bienestar de la persona mayor
Nutrición, nutrientes y grupos de alimentos
Dieta balanceada
Deficiencia nutricional
Fórmulas nutricionales
Técnicas de preparación de alimentos
Asistencia en la alimentación

Glosario

Autocuidado: capacidad de una persona para participar y realizar acciones orientadas al cuidado de su salud, bienestar y necesidades cotidianas, de acuerdo con sus capacidades.

Autonomía: capacidad de la persona para tomar decisiones y participar en las actividades de su vida cotidiana de acuerdo con sus capacidades y preferencias.

Bioseguridad: conjunto de medidas y prácticas destinadas a prevenir o reducir

Cuidado integral: atención que considera de manera conjunta las necesidades físicas, emocionales, sociales y funcionales de la persona, promoviendo su bienestar, seguridad, autonomía y dignidad.

Dependencia funcional: situación en la que una persona requiere apoyo de otra para realizar una o varias actividades de la vida cotidiana.

Disfagia: dificultad para realizar de manera adecuada el proceso de deglución de alimentos o líquidos.

Envejecimiento: proceso natural del ciclo vital que comprende cambios físicos, psicológicos y sociales y que se desarrolla de manera diferente en cada persona.

Fragilidad: condición asociada con una disminución de la reserva y capacidad de respuesta del organismo, que puede aumentar la vulnerabilidad ante diferentes situaciones.

Higiene cefalocaudal: procedimiento de higiene corporal que sigue una secuencia organizada desde la cabeza hacia los pies, procurando mantener la limpieza, comodidad e integridad de la piel.

Multimorbilidad: presencia simultánea de dos o más enfermedades o condiciones de salud en una misma persona.

Nutrición: proceso mediante el cual el organismo obtiene, utiliza y aprovecha los nutrientes necesarios para mantener sus funciones.

Persona mayor: persona que se encuentra en la etapa de la vejez del ciclo vital y que debe recibir un cuidado que respete sus derechos, dignidad, autonomía y características individuales.

Precauciones universales: medidas de protección que se aplican durante el cuidado para reducir el riesgo de exposición y transmisión de agentes infecciosos, independientemente de que exista o no una infección conocida.

Valoración: proceso de recopilación y análisis de información sobre las condiciones, capacidades, necesidades y riesgos de una persona para orientar el apoyo requerido.

Vulnerabilidad: mayor posibilidad de una persona de verse afectada por determinadas condiciones o situaciones debido a sus características individuales o de salud.

Referencias bibliográficas

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125

Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley 1251 de 2008. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=33964

Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1315 de 2009. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36834

Congreso de la República de Colombia. (2017). Ley 1850 de 2017. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82917

Desnutrición. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/prevenir-la-malnutricion-o-desnutricion.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Decreto 681 de 2022. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%20681%20de%202022.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Organización Mundial de la Salud. (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. https://apps.who.int/iris/handle/10665/186466

Organización Mundial de la Salud. (2020). Prevención y control de infecciones.

Organización Panamericana de la Salud. (2017). Envejecimiento saludable.

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2020). ¿Cómo lavarse las manos de una forma segura? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=N5iWzjNWh8A

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Laura Briguitte Perea Possos	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Viviana Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sebastian Trujillo Afanador	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima